

药物相互作用一览

苯妥英钠+氯霉素→中毒
强心甙+皮质激素→加重心衰
青霉素类+磺胺类→拮抗作用
氨基糖苷类+强利尿药→耳毒性增强
抗癌药+皮质激素→免疫系统抑制加重
口服降糖药+保泰松→有致低血糖的危险
西咪替丁+茶碱→出现严重不良反应而致死
吩噻嗪类+解热止痛药→体温急剧下降的弊病
利福平+异烟肼→肝毒性增大,个别可发生肝坏死
口服避孕药+灰黄霉素→引起月经紊乱和避孕失效

.....

药物相互作用带来的 困扰

Kelly Dowhower Karpa Ph.D. R.Ph

药理学专业的学生们对药物相互作用经常会有这样一种理想化的观点：如果两种药物有相互作用，就不应将这两种药物一起使用。不幸的是，现实世界中并不是这么简单的。事实上，药师们每天都会给患者开出一些有体内相互作用的药物。

那么药师怎样通过减少药物相互作用所带来的影响而提高治疗效果呢？难道关于药物相互作用的警示根本不重要，只是在浪费时间吗？这一问题以及相关的议题在 Las Vegas 举行的美国医药卫生协会（ASHP）第40届年中临床会议中进行了讨论。这次的讨论集中于一个复杂的、难解决的问题，尽管有一个问题已经理清，但并不是所有的专家都满意。

据加拿大 Sunnybrook 医院的药剂师 David Juurlink 博士说，面对几百种有相互作用的药物，即使最勤奋的、时刻关注该领域研究进展的医师也很难做出判断。药物相互作用的复杂性让人感到困惑，而且也在变得更加复杂。

但是，事实上，药物在体内的相互作用并不都是至关重要的；只有当这种相互作用对患者造成危害时才会变得较为重要。也就是说药物相互作用的严重性和重要性是取决于患者的。而患者之间的差异是非常大的。Washington 医疗中心药理系的副主任、药学教授 John Horn 博士说，在比较两种药物（有相互作用）的研究中，患者个体之间的差异可以达到5到7倍。

目前的电脑程序还不能够分析导致患者个体差异的各种因素，如遗传学、共病率、环境、是否吸烟或喝酒、药物剂量、给药持续时间、给药途径、药物配方以及给药时间点等因素。Horn 说，要解决这些影响因素所致的个体差异问题，就不要再依赖于电脑软件进行分析，而是要用“两个耳朵之间的那部电脑”来分析。

尽管这些药物相互作用非常令人困扰，但是用电脑分析出来的药物相互作用的警示确实有它的价值。这些警示可提高对患者治疗的安全性，并能给药师提供一定的信息。在临床研究中，开处方者都愿意接受这方面的相关教育，因为他们可由此学到关于药物相互作用的一些新的信息。Washington 大学药学系的教授 John Murphy 博士说，一旦有新的药物相互作用报告，开处方者一般都会据此做出相应的调整。但是，他提醒到，当给医师们发出药物相互作用的警示时，要准备好提供出可选择的无相互作用的药物。

在 ASHP 会议中开展此次讨论的药师专家们认为，分析药物相互作用的软件应该进行更新，以能够提供

可靠的建议。而且不仅要能够筛选出有相互作用的药物，药师们还应开发出可以筛选可选择的、更有效的药物的软件。

但有时并没有其他药物可以选择、替代，而且必须要用这组有相互作用的药物进行治疗。那在这样的情况下，药师如何处理药物的相互作用呢？Horn 提出几点基本的策略：

①如果有可供选择的药物，就调整为其他种类无相互作用的药物。

②如果没有可供选择的药物，就采用药物代谢动力学分析药物的清除情况，分析其血药浓度，并调整剂量，以将药物的相互作用降至最低。

③总的来说，要对患者进行监控。对患者进行监控就可以在发生不良反应之前，能够及时发现、并控制药物在体内的相互作用。

不幸的是，药师们在自己的电脑里看到那么多药物相互作用的警示，而且这些警示信息也是他们的得意之作，但他们还是常常不加思考就忽略掉这些信息。因为电脑里的这些信息很多对于临床来说都是无关紧要的，药师们也常常因此受到批评。例如，对于患者可以耐受的再处方的药物、甚至 3 年前就停用的某种药物以及对于某种药物的局部应用等等，电脑也会给出一些无用的警示。Murphy 认为，这些药物相互作用的警示属于“狼来了”现象。

据 Murphy 介绍，如果药师们能够将这些警示规范化，使得医师、药师很难或不可能忽略掉有生命危险的警示，那有关一些问题是能够被解决的。但是还

存在一个矛盾就是，哪些警示才应收入这个目录。例如，在 4 份不同的参考资料中共有 406 个严重的药物相互作用报告（注：这项分析主要针对严重的药物相互作用，并不包括中度或轻度的相互作用）。然而，在这些报告中，在 4 份参考资料中都有列出的仅有 9 对有相互作用的药物，而且只有 35 对有相互作用的药物在其中的 3 份参考资料中都有包括。

为什么会出现这样的矛盾呢？而且这样的矛盾就会导致无法产生一个国际统一的药物相互作用的分类系统。不同的电脑系统用的是差异很大的药物相互作用分类标准。在某一项资料中由于严重的不良反应报告而被列为严重药物相互作用的，在另一份资料中可能就被归为中度或轻度的相互作用。另外还有一些分类标准可能是基于已有的特殊不良反应事件的资料（例如，仅在一个病例中报道过的药物相互作用，与在文献中已进行详细描述、且机制已较为清楚的药物相互作用，两者的严重性就不可能是一个程度的）。

Horn 说，主要问题在于“人们将一个实际上很复杂的问题处理的太简单化了”。他建议，所用的软件应该能够比较容易的进行调整，药师们应该能够通过软件，根据药物相互作用对患者的影响情况，将其归为不同的严重级别。

虽然 ASHP 举办的这次药物相互作用的论坛中，药师们分别持有几种不同的意见，但有一点是大家比较一致的，就是进行药物相互作用分析的软件需要进行更新。🔥（资料来源 *Drug Topics*, Apr 17, 2006. 编译 于丽）

名刊浏览

BMJ

调脂治疗可降低心血管危险性

2006 年 4 月 3 日发表于 *BMJ* 杂志上的一项研究表明，调脂药物治疗可显著降低糖尿病和非糖尿病患者的

的心血管危险性。研究者们 (Costa J, Borges M, David C, et al) 为评价调脂药物治疗对糖尿病和非糖尿病患者的

一级和二级预防作用，采用系统回顾和 meta 分析的方法，选取的研究均为随机、安慰剂对照、随访至少 3

年的双盲临床试验，研究目的均为调脂治疗对糖尿病和非糖尿病患者疗效的评价。初级观察终点为主要冠状

动脉事件，即冠心病所致的死亡、非致死性的心肌梗死或心肌血运的重建。

共纳入 12 项研究进行 meta 分析。结果发现调脂治疗对于糖尿病患者和非糖尿病患者同样有效。对于糖